2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

# PROVA TUBERCULÍNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AVALIAÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gledsângela Ribeiro Carneiro[1]
Jones Sidnei Barbosa de Oliveira[1]
Valerio Severino da Silva[1]
Vânia Pinheiro Ramos[2]

[1] Secretaria de Saúde do Recife – SESAU
[2] Universidade Federal de Pernambuco- UFPE

Fonte: https://www.facebook.com/NoCaminhoDaEnfermagem/posts/950744908411081/

**A realização da prova tuberculínica por profissional de enfermagem na Unidade de Saúde da Família ampliou o número de contatos avaliados, alcançando 90% de cobertura. Considera-se que contatos não avaliados podem desenvolver a doença. Na aérea adstrita estima-se cerca de dois casos anuais, tornando viável a avaliação dos contatos sem sobrecarregar a equipe. Aprendizado: a descentralização da prova tuberculínica na Atenção Primária ampliou o acesso, reduziu barreiras logísticas e aumentou a adesão dos contatos, fortalecendo a vigilância e o controle da tuberculose no território.**

## INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma doença infecciosa milenar que permanece como importante problema de saúde pública, apresentando elevada morbimortalidade em escala global, sendo superada entre as doenças infecciosas apenas pela COVID-19 no período da pandemia. No Brasil, a doença mantém distribuição heterogênea, com maior concentração em áreas urbanas e populações vulneráveis (Brasil, 2021).
A avaliação de contatos de pessoas com tuberculose constitui uma das principais estratégias para interrupção da cadeia de transmissão, permitindo a identificação precoce de casos latentes e a instituição de medidas preventivas. Nesse contexto, indivíduos assintomáticos devem ser submetidos à prova tuberculínica (PT) e, quando reatores, com radiografia de tórax sem alterações sugestivas de doença ativa, recomenda-se a instituição de quimioprofilaxia, geralmente com esquema semanal por 12 semanas.
Entretanto, apesar da relevância dessa estratégia, persistem desafios significativos para sua efetivação, como o estigma social associado à doença, dificuldades de acesso aos serviços de saúde, necessidade de duas visitas para aplicação e leitura da prova tuberculínica, além de custos indiretos relacionados ao deslocamento. Tais fatores contribuem para baixa adesão dos contatos e comprometem o controle da doença no território (Brasil, 2021).
Diante desse cenário, estratégias de descentralização das ações para a Atenção Primária à Saúde (APS) mostram-se fundamentais para ampliar o acesso e fortalecer a vigilância em saúde.

## OBJETIVO

Apresentar a experiência de ampliação da realização da prova tuberculínica e da adesão de contatos de pacientes com tuberculose em uma Unidade de Saúde da Família de uma capital Nordestina.

## MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido em uma Unidade de Saúde da Família (USF) localizada em uma capital da região Nordeste do Brasil.
A intervenção consistiu na descentralização da realização da prova tuberculínica para a própria unidade, com capacitação de profissional de enfermagem para aplicação e leitura do teste, anteriormente restrito a serviços de referência. Foram adotadas estratégias para identificação ativa dos contatos de pacientes diagnosticados com tuberculose, bem como organização do fluxo assistencial para facilitar o acesso desses indivíduos à avaliação.
Os dados foram obtidos a partir de registros da unidade, considerando o número de contatos identificados, avaliados e submetidos à prova tuberculínica. A análise foi realizada de forma descritiva, com cálculo de cobertura de avaliação dos contatos.
Por se tratar de relato de experiência com dados secundários e sem identificação dos indivíduos, o estudo respeita os princípios éticos vigentes, dispensando submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

## RESULTADO

A implementação da prova tuberculínica na própria Unidade de Saúde da Família, realizada por profissional de enfermagem, possibilitou ampliação significativa do número de contatos avaliados, atingindo cobertura de aproximadamente 90%.
Observou-se que a descentralização da ação reduziu barreiras de acesso, facilitando o comparecimento dos contatos e permitindo maior agilidade no processo de avaliação. Considera-se relevante destacar que contatos não avaliados permanecem em risco de desenvolver a doença, contribuindo para a manutenção da cadeia de transmissão.
Na área adstrita da unidade, estima-se a ocorrência de cerca de dois casos novos de tuberculose por ano, o que torna operacionalmente viável a avaliação sistemática dos contatos sem sobrecarga significativa da equipe de saúde.

## DISCUSSÃO/APRENDIZADO

A experiência evidencia que a descentralização da prova tuberculínica para a Atenção Primária à Saúde constitui estratégia efetiva para ampliação do acesso e aumento da adesão dos contatos. A atuação da equipe de enfermagem mostrou-se fundamental nesse processo, ampliando a resolutividade da unidade.
Além disso, a redução de barreiras logísticas, como deslocamento e necessidade de encaminhamento para outros serviços, contribuiu diretamente para o aumento da cobertura de avaliação. Tais achados reforçam a importância da organização dos serviços de saúde centrada no território e na proximidade com a população.

## CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A descentralização da prova tuberculínica na Atenção Primária à Saúde mostrou-se uma estratégia eficaz para ampliar a avaliação de contatos de pacientes com tuberculose, reduzir barreiras de acesso e fortalecer as ações de vigilância e controle da doença. Iniciativas semelhantes podem contribuir significativamente para a melhoria dos indicadores de controle da tuberculose em contextos similares.

REFERÊNCIA

BRASIL, Ministério da Saúde. Tuberculose. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose. Acesso em: 15 abr. 2026.

Gledsângela Ribeiro Carneiro
Secretaria de Saúde do Recife

E-mail: gleds_r1@hotmail.com
Contato: 81 98532-8811

RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE
POR VOCÊ, TRABALHANDO SEM PARAR.